	身份證	消化號 鏡專 R	身分證後五碼
劉冠廷	**A129139376**	**T112089** **R112076**	**39376**
何沛桓	**F129447207**	**T112095** **R112075**	**47207**
陳昱廷	**Q124074695**	**T112092** **R112077**	**74695**
吳泰錡	**T124035244**	**T112087** **R112078**	**35244**
孟明蓉	**A228778353**	**T112090**	**78353**
郭曜瑋	**E124549590**	**T112091**	**49590**
游仁	**B123037338**	**T112094** **R112079**	**37338**

	內專編號	證書號
劉冠廷	**012306**	**012589**
何沛桓	**012538**	**012840**

檢驗開立

HBV DNA 定量檢驗	M23-078
HCV RNA 定量+基因型	M23-079+108
ICG test	開抽血+藥(>50kg 2PC,<50kg 1PC)

常用診斷

肝原發惡性腫瘤/肝細胞癌	C228(沒patho)/C220(有patho)	膽囊惡性腫瘤	C23
肝內膽管癌/未明膽管癌	C221/C249	胰臟頭/體部惡性腫瘤	C250/C251
肝、膽囊及膽道性態未明腫瘤	D376	十二指腸壺腹惡性腫瘤	C241
胃惡性腫瘤	C169	肝硬化	K7460
肝臟衰竭重大	K7460		

影像科(櫃檯 2570、電腦斷層 2585#316、血管攝影 2585#323/324、急診電腦斷層 2568)

Fluoroscopy	X75-981	食道氣球擴張、放 N-D tube 請開 M23-002 + X75-981（guide wide自費約1500）
Liver CT	X75-992	不指定：地點都可 有指定：病理大樓, 檢查單註記(O), 電聯醫師(X), 聯絡X科(X)
Liver MRI	X75-989	不指定：地點都可 有指定：選病理大樓, 電聯醫師(O), 檢查單註記(O), 聯絡X光科(X) - Dr. 曾振輝排W1 or 6 .如果VS有說想看到小顆腫瘤, 想自費顯影劑 Primovist (Gadoxetic acid), 於檢查單上註記並與病人說明即可, 不需聯絡檢查室, 自費單會於檢查室簽(約2000-3000)
CT-guided biopsy	X75-983	CT-guided biopsy of abdomen
TACE of liver	X75-896	1.同意書一份 2.若有指定VS需電聯VS本人 3.可以直接丟單等檢查室通知時間即可, 不需要打影像科電話確認時間 4.請CR開化療藥：化療模組 -> C220/228 -> 全院 -> 倒數第五個 -> 藥物第2個Doxyrubicin 20mg(2PC)存檔 -> 最上面選S/E, ECOG, cycle -> 存檔送出,選擇不帶入檢驗

內治中心**(2217), 一般胃鏡室(2227, 2228)**

檢查	代碼	內容
胃鏡	M23-002	Panendoscopy **只有NC 3L以下才可以排 否則一律on endo才能出 吐血多也要on endo做, protect airway

減痛上	M23-120	Endoscopy under sedation and analgesia 自費2000
大腸鏡	M23-013	Colonofiberscopy **務必清腸: PEG 1pc once or 保可淨 2pc once 當天早上沒乾淨再給Fleet enema 1 or 2pc once
乙狀結腸鏡	M23-012	Sigmoidoscopy, flexible ** 2pc Fleet enema once 檢查1-2 hrs前
減痛下	M23-121	Colonoscopy under sedation and analgesia 自費2500
減痛上+下	M23-122T	Endoscopy & Colonoscopy under sedation and analgesia 自費3000
POEM EMR/ESD	M23-002	+ 全身麻醉:會診麻醉科，請 CR 輸入排程(借房120,72050B), Percutaneous 的endoscopy 麻醉科醫師會說明自費 + 備 LPRBC & FFP & platelet. Keep ivf + 最晚前一天16:00電聯麻醉阿長 吳沛穎護理長GSM :68384 EMR/ESD 同意書: 消化道內視鏡粘膜下層剝離-粘膜切除。 食道 RFA 同意書: 消化道內視鏡檢查 ESD : Triamcinolone acetonide 4pc spray 預防食道狹窄 ***要全麻就一定要輸入排程，不論檢查種類 EMR下，通常不用全麻，需輸入排程
食道RFA	M23-085	
EV ligation	M23-009	Esophageal varices ligation
GV sclerotherapy	M23-081	Gastric variceal sclerosing therapy
膠囊	M23-082	Capsule endoscopy **前一晚一定要NPO！！！ **清腸：前一晚gascon 1PC, PEG 0.5PC **健保做之前確認有兩上兩下，自費的話基本要一上一下 1.早上八點到胃鏡室去，簽名(同意書)跟病患解釋: 待會膠囊吞下去到胃，一兩個小時會再到檢查室來看有沒有到小腸了，如果沒有的話可以用促進腸胃蠕動的藥物試試，所以你待會吞下去的時候盡量一直走動，讓膠囊下去。 2.如果還是沒有下去，我們會安排胃鏡的方式把膠囊推下去，因為膠囊有電力限制 (約12~13個小時)，不能讓他一直待在胃裡面耗電。 3.之後膠囊會自行排出，時間不定，看你消化好不好。膠囊在人體內不會有害，曾經我們遇過最久的事在體內待一個月。但如果是真的有阻塞結構病理的問題，就會需要用手術取出，但機率很少，本院來從來沒發生過，但就算發生了我們也能夠處理(開刀)。 —以上解釋部分— 4.再來是看影像，病患身上都會背一台小的MONITOR可以看到膠囊拍攝出的影像(按中、左、右就會有影像)，我們要做的就是他吞下去後我們看著他一路掉到胃裡，就可以請他上去

		了。然後技術員姐姐會跟他約再下來看有沒有到小腸的時間(通常是2hrs後)，你們再在那個時間下來看第二次。 5.確認有在小腸就收工，沒有的話，打一支Primperan IV再請他繼續活動，同時跟李柏賢醫師報告(或是安排檢查的醫師報告)，打一支Primperan一個小時後都還沒下去，跟主治醫師報告要出胃鏡把膠囊推下去。 6.中間有不確定不清楚的地方都可以直接照起來影像TEAMPLUS給柏賢哥或直接打給他 自費耗材代碼：84-971-GS0391QZ 自費total約4到5萬 耗材36000 判讀費10000多
小腸鏡	M23-023	Deep enteroscopy 確認檢查從上做/從下做 +全麻會診麻醉科 +聯絡麻醉科阿長(電話可能會變 可以問NP)
EUS	M23-051 M23-051B M23-120	Electronic endoscopic ultrasonography Miniprobe endoscopic ultrasound Endoscopy under sedation and analgesia (自費2000) 針8000-13000下去簽
EUS-FNA	M23–052 M23-120	Endoscopic ultrasound guide fine needle aspiration (自費7800) Endoscopy under sedation and analgesia (自費2000) 材料費約14000下去簽
ERCP	M23-004 X75-751 M23-120	ERCP E.R.C.P. Endoscopy under sedation and analgesia (一定要，自費2000) 三張檢查單跟兩份同意書 病解可以先說金屬支架6.5萬左右 預防性抗生素1pc before ERCP then x 1 day 需不需要預防性塞劑要看VS **PLT 6-8萬以上即可 PLT 8萬以下要輸血至少12U 並告知檢查室，不須recheck更低可能要輸24U並recheck **火雷射要consult麻醉科全麻 **季桓routine 當天早上塞inteban 4pc once+run LR IVF+Rocephin 2pc IV once and QD另外：若是切papilla的mass怕出血，可能會run somatostatin 2pc in NS 500cc run 200cc/hr 一天
腸道金屬支	M23-080	Esophageal metal stent placement

架	X75-981 M23-120	Fluoroscopy 是否sedation
ARMA	普通胃鏡 M23-206	普胃同意書 不用key 排程
Pancreas RFA		
ESG	M23-203	Endoscopic sleeve gastroplasty 全麻(會麻醉科,麻醉阿長), 上排程
放胃內水球	M23-025A	BIB(Bioenterics intragastric ballon) implantation
取胃內水球	M23-025B	BIB(Bioenterics intragastric ballon) remove

急性肝炎 法定特殊傳染病

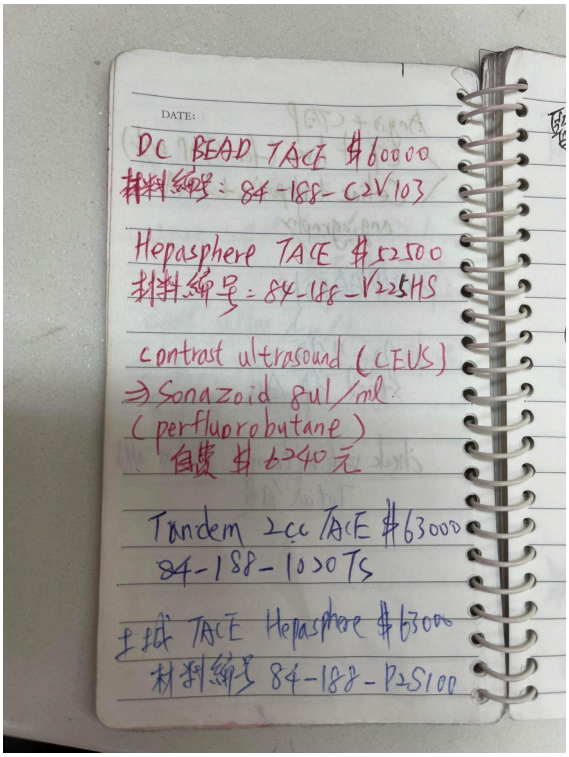
- 提報傳染病即可送驗(本院無法驗)

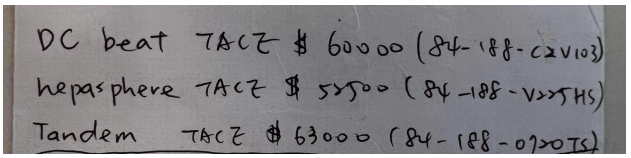
三加一

1鉤端螺旋病
2Q熱
3地方性斑疹傷寒
4恙蟲

特殊TACE

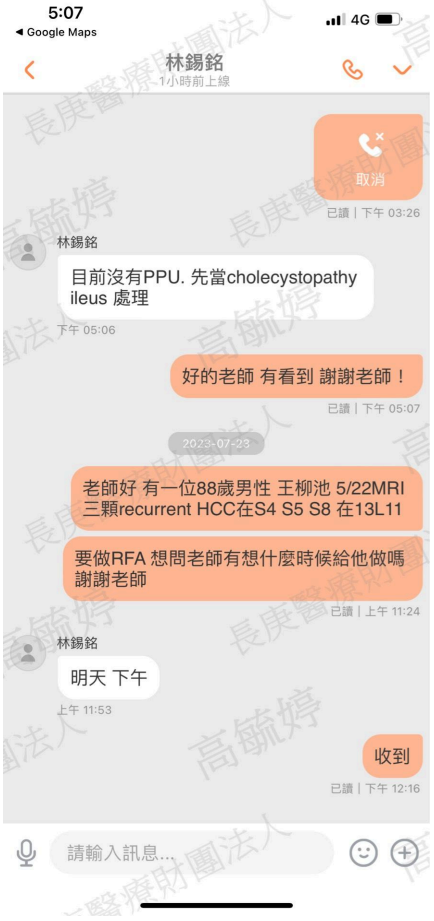
1.特別的TACE要用這個代碼給病人簽，從同意書-管理部-自費特材進去
2.特殊的TACE只要給同意書 檢查室會自己開藥 我們不用開藥
不然病患會被重新開藥變兩倍價錢
→如有不確定 一律打電話去TACE檢查室確定要不要開藥
→若劑量不確定也打電話 劑量通常會寫在住院單或門診紀錄





超音波室(分機：**2225, 2235)**

檢查	代碼	內容
腹部超音波	M23-034 M23-032	Abdominal echo, liver, pancreas, spleen Echo, follow (半年內做過就開這個)
Drainage	M23-043A/B	Drainage of cyst or abscess of liver/ subphrenic abscess
Aspiration	M23-041	Echo guide aspiration
Liver Biopsy FNAC	M23-042 M23-041A/B	Echo guide biopsy　肝臟生檢 **@@注意：病人cons必須M6 clear obey，因為怕出血、亂動危險，尤其biopsy完還要加壓六小時 **真的不得已，可以打M23-123 sedation去做，但要執行的主治醫師同意做才行 Abdominal puncture 肝臟細針抽吸細胞學檢查
RFA	M23-046? M23-123	Radiofrequency ablation (?依腫瘤大小選 A < 3cm/B /C > 5cm) –選最大顆的即可，不要選到放射診斷科的RFA order Liver tumor radiofrequency ablationM23-123(開此order會列出鎮靜同意書) 1 一定會收自費鎮靜約2500(系統會跳)，針則要確認健保或自費 (查詢->專案事前報備資料) (需文字醫囑註記) **另外跳出來7000的自費同意書不必理他，是系統誤跳，其實RFA沒

		有技術費需要付..所以是佛心事業無誤 2 聯絡VS檢查時間 3 聯絡檢查室2235 2227 4 同意書共兩份(RFA + sedation) @@注意：病人cons必須M6 clear obey，因為怕出血、亂動危險 *週末進來 錫大大的病患都要跟錫大大確認病患RFA時間跟要不要自費打sonazoid(超音波顯影劑自費7千）  我

藥物

Somatostain 2/500/20	2 < PC in NS 500ml, challenge 80ml, run 20 ml/hr
Octreotide(Sandostatin 目前缺藥物) 6/500/20	6 or 12 PC in NS 500ml, challenge 20ml, run 20 ml/hr (25-50mcg/hr)
high dose PPI	2PC in NS 100ml run 10 ml/hr or 1PC in NS 100ml run 20ml/hr
NAC	NAC 1.5PC in D5W 250ml run 1hr

	then 2 pc in d5w 500ml run 30 ml/hr for 4 hr then 2 pc in d5w 500ml run 15ml/hr for 67 hr
Stronger	Glycyrrhizin 3 pc QD IVx 3days**需自費一天要900 total 2700

免疫治療HCC

A+B: 要確認自費或健保、第幾次
-自費:第一次(買A送B), 第二次(買A送B), 第三次(買B送A), 每三次一個循環, 藥物劑量和前一次一樣
-健保:從2023.8月以後健保給付→改成都是買A(自費9萬多)送B不論第幾次

學術活動

活動	時間	負責	報告	其他(場地/VS/內容)
Morning meeting				
HBV conference	每月2場	F1	F1	
Liver CPC	每月1場	F2	R3	
Teaching round	每月2-4場	F1	clerk	
Fellow seminar	每月3場	Fellow	Fellow	
Image reading	每月1場	F1	F1	
RFA conference	每月1場	F1	F1	
R3 case conference	每月1-2場	F2	R3	
GI-GS conference	週四 16:30			打給個管師莉玲學姊67651, 簡單說是什麼case、提出來想討論什麼、由哪位醫師負責報告
HCC conference	週三 17:00			
IBD conferenece	每月一場 週三 16:30			

簽床事宜

1. Discharge today(書記放床); discharge tomorrow (開order當下放床)

2. 簽床流程:先確認今天有幾張要簽住院，然後去床位系統(找預住院病人/改成日期不拘)輸入病例號查詢床等
3. 床等:看「順序」0 特等 1 單人 2 雙人 3 健保
4. 下去住院服務中心 最裡面找英冠姐(代號DTA)，找出我們要的住院單，上面蓋上「因病情需要優先住院」
5. 打給樓上書記放床(today)或是請別人開立order(tomorrow)，然後立刻遞給英冠姐簽床
6. 目前規定不能跨區簽，解方有兩個 (1) 沒床就找5C (2) 5C也沒床，可以考慮住院單改成加等其他病房Services XXX
7. (上面第二個辦法)跨區簽有些住服姊姊很堅持，是不能改services的
8. 如果真的住不進來，就打給VS老實說進不來，然後請病人回OPD約時間
9. 可以問病人要不要提早住院(提早一天沒問題)避免當天沒床
10. 美女與肥肉裡面會通知簽床的個案，記得回覆「以上已登記，謝謝」

普通病房簽床

1.簽床電子表單 https://reurl.cc/1oZNmm
2.預住院清單 https://reurl.cc/xE9V1Z
3.李柏賢/ 李青松門診病人不轉service (到其他病房也是)
4.[8A] 每個Team 12床(最多可以14) 徐正二Team會比較少床

5.8B 每個team 最多14床. 盡量不要轉Dr.李柏賢's service(老師很容易爆床，他還會有很多外圍的病人)
＊＊＊陳聰興醫師門診簽床需要fellow本人(而不是當team住院醫師)跟陳醫師報告病人住進來，可用teamplus聯絡

6.[8C] total 50床，每個team 12床，盡量13床以內
原則--如果爆床:除"會親自來查房**service的VS**"一定要給該team外，同team VS OPD的病人可以均分給其他組
e.g.錫大大病人原本會是分給第二組，但第二組已滿就可以均分給其他組，因為錫大大本人不太會親自來病房
@Dr.陳正仁 team:因OPD病人較少，急診可盡量給這組
@注意:2023/8月service目前不照最新班表上的，而是改成以下
第一組:「陳益程醫師2391」**+謝彝中醫師**
第二組:「林伯庭醫師0480」
第三組:「陳正仁醫師3579」
第四組:「劉彥君醫師8254」**+滕威醫師+林俊彥部長(如果爆床的話，林院長的病人不用放在這一組)**
「」括號為on service醫師，**其他醫師為每個禮拜其他天會"親自"來病房查房主治醫師**

7. 鄒永寬簽進來要ESD的病人要交病人使用全家寶app(可加業代line問怎麼用)

病房CR盡量跟查房

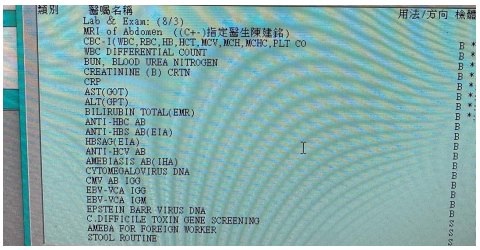
8C護理站電子白板有寫部長查房是禮拜幾，目前是禮拜四
*8C必跟林俊彥部長查房

排班表

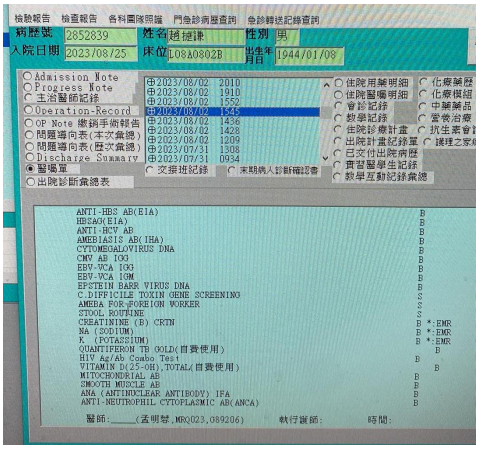
PGY1 上限10; PGY2 上限 14; R 上限15; NP 無上限
同team 互cover 為原則. NP不跨team cover.
Day off cover 優先排flow NP. 人力真的不夠可以排小夜NP

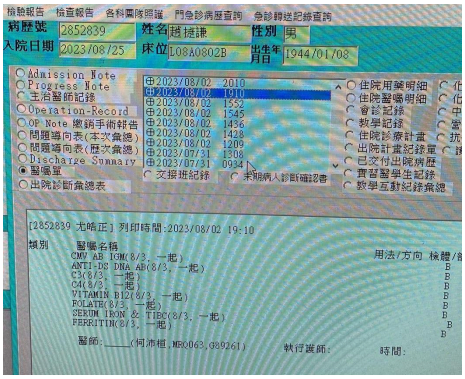
IBD routine

Quantaferon TB gold 會跳自費 但我記得我們醫院有補助



is

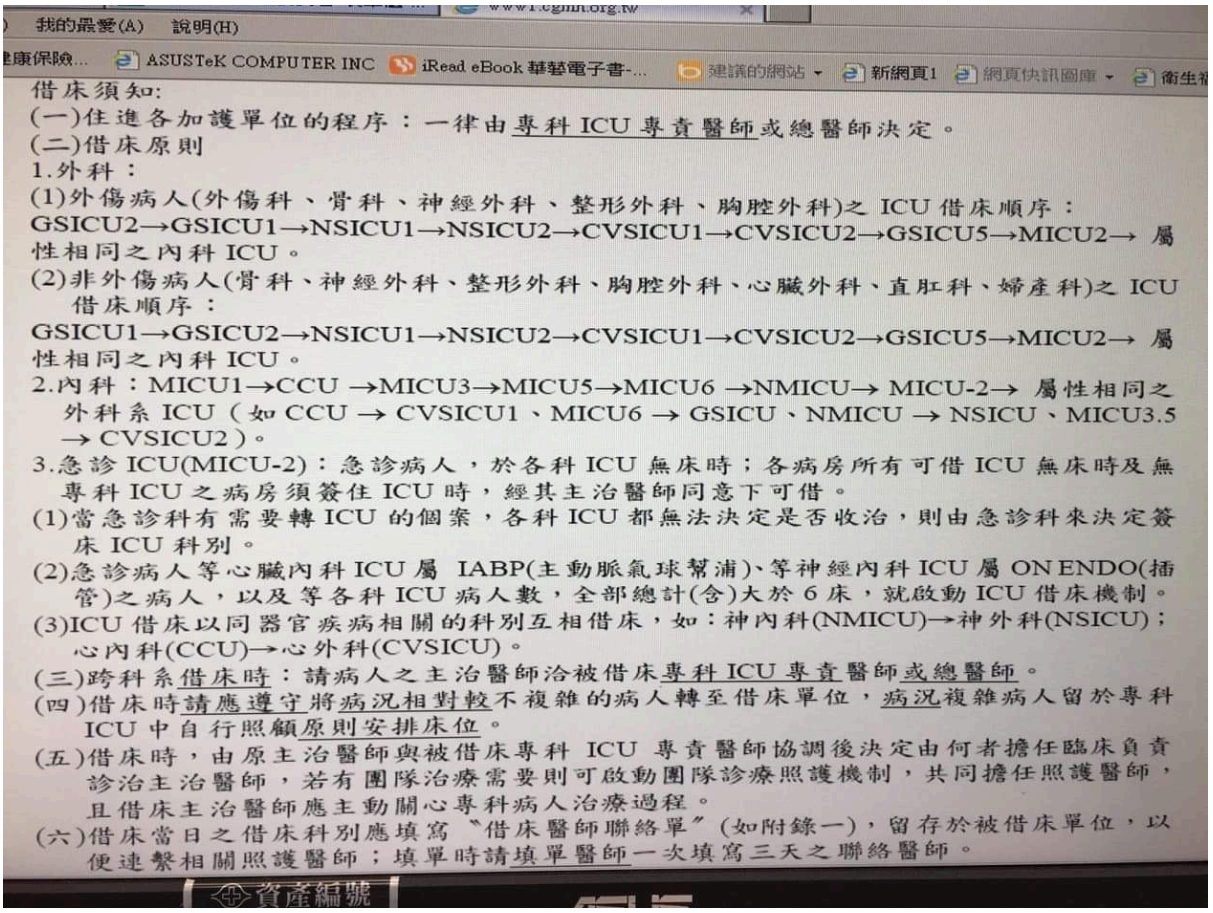




MICU6簽床

1. 步驟 (1)跟leader說 (2) 簽床本 (3) 白板
2. 注意:
    2.1. 盡量避免48小時再入, 否則MICU6主治醫師要寫報告

2.2. 當班前30分鐘簽，就是當班接
2.3. 白天盡量兩點前寫白板，三點前接病人，否則會撞在一起


借床須知:
(一)住進各加護單位的程序：一律由專科 ICU 專責醫師或總醫師決定。
(二)借床原則
1.外科：
(1)外傷病人(外傷科、骨科、神經外科、整形外科、胸腔外科)之 ICU 借床順序：
GSICU2→GSICU1→NSICU1→NSICU2→CVSICU1→CVSICU2→GSICU5→MICU2→ 屬性相同之內科 ICU。
(2)非外傷病人(骨科、神經外科、整形外科、胸腔外科、心臟外科、直肛科、婦產科)之 ICU 借床順序：
GSICU1→GSICU2→NSICU1→NSICU2→CVSICU1→CVSICU2→GSICU5→MICU2→ 屬性相同之內科 ICU。
2.內科：MICU1→CCU →MICU3→MICU5→MICU6 →NMICU→ MICU-2→ 屬性相同之外科系 ICU（如 CCU → CVSICU1、MICU6 → GSICU、NMICU → NSICU、MICU3.5 → CVSICU2）。
3.急診 ICU(MICU-2)：急診病人，於各科 ICU 無床時；各病房所有可借 ICU 無床時及無專科 ICU 之病房須簽住 ICU 時，經其主治醫師同意下可借。
(1)當急診科有需要轉 ICU 的個案，各科 ICU 都無法決定是否收治，則由急診科來決定簽床 ICU 科別。
(2)急診病人等心臟內科 ICU 屬 IABP(主動脈氣球幫浦)、等神經內科 ICU 屬 ON ENDO(插管)之病人，以及等各科 ICU 病人數，全部總計(含)大於 6 床，就啟動 ICU 借床機制。
(3)ICU 借床以同器官疾病相關的科別互相借床，如：神內科(NMICU)→神外科(NSICU)；心內科(CCU)→心外科(CVSICU)。
(三)跨科系借床時：請病人之主治醫師洽被借床專科 ICU 專責醫師或總醫師。
(四)借床時請應遵守將病況相對較不複雜的病人轉至借床單位，病況複雜病人留於專科 ICU 中自行照顧原則安排床位。
(五)借床時，由原主治醫師與被借床專科 ICU 專責醫師協調後決定由何者擔任臨床負責診治主治醫師，若有團隊治療需要則可啟動團隊診療照護機制，共同擔任照護醫師，且借床主治醫師應主動關心專科病人治療過程。
(六)借床當日之借床科別應填寫〝借床醫師聯絡單〞(如附錄一)，留存於被借床單位，以便連繫相關照護醫師；填單時請填單醫師一次填寫三天之聯絡醫師。

急會診

- 範本66524 蘇以哲、39000、35967

上午:出portable echo

- 8-10點接電話: EGD ECHO
- **超音波機器到檢查室 侵入性處置那間推機器**
- 出portable: 收件 聯絡F2約時間 上傳影像
- 交班下午EGD:床號 病例號 為什麼做 同意書

下午: 出portable EGD

- 急內視鏡:聯絡VS確定時間->技術員(內治，平日盡量13:00前)->F2->當科準備
- 告知當科事項
    a. EGD: 左側臥, oral bite, NG irrigation(30min前)
    b. ND: 左側臥, oral bite, 整縫包, 2.0-3.0 Nylon 線
    c. Sigmoid: fleet enema 2pc once before 1 hr sigmoidoscopy

技術員	Tel	技術員	Tel
(-) 王菀資	0912-882-722	呂沛翎	0988-260-471
謝麗芬	0937-967-588	曾莉婷	0937-321-449

鍾宛真	0919-643-977	溫莉茹	0960-711-223
翁嘉怡	0978-108-673	簡曼庭	0918-101-062
林佩萱	0988-167-159	卓玟琇	0980-209-293
林宥杆 林宛怡(舊名)	0977-239-565	吳逸雅	0936-217-490
陳佳鈴	0961-188-187	張薏玲	0963-088-197
陳霈慈	0982-133-280	李莉萍	0970-895-560
陳翔婕	0919-351-675	游盈禎	0975-530-254
陳怡靜	0921-177-137	楊雅如***	0975-365-138
黃桂英	0937-315-739	許芳瑜	0911-100-024
黃美蓉	0920-006-790	郭蘭芳	0987-993-292
洪美旬	0960-598-765	吳豔櫻	0983139202

秘書

秘書	分機	email	業務
蔡宜蓁	8107	linda1220@cgmh.org.tw	科系秘書+肝臟科業務
許效慈	8102	stacey@cgmh.org.tw	住院醫師+顧問級醫師
吳婉華	8101	sharon0124@cmgh.org.tw	胃腸科業
黃圓媛	8108	Bluelove00@cgmh.org.tw	膽胰科業務

值班

1.點交接31200，平日16:00-22:00後，假日08:00-22:00後，達成率90%
2.晚上9點和老闆報告new case

特殊病房

1.

超音波室

找最資深的**cover**

1.邱主任超音波診
    (1) 查上禮拜的biopsy，檢查事務->報表，0508

2. 謝森永醫師超音波
會讓你在隔壁掃 不用掃很急 掃完老師會過來重新掃一次並跟你說報告怎打

病房工作事項

- Orientation記得跟clerk學弟妹說要跟Fellow學echo還有內視鏡喔
- 「來自內視鏡VS」
    - 請病房CR宣導病房如果出血下去做內視鏡 早上HB不到7 輸完血下去前要再recheck HB有沒有到7喔

打報告小技巧

暫存時先不要打**VS**代號 會跳到**VS**那邊 我們會看不到

普通胃鏡

1.沈一嫻醫師胃鏡:

- 總共大概10-15台
- 老師一開始會讓你在旁邊看 問你問題(可當場查) 或者要你查東西
- 有可能會讓你試試看sedation的病人 各種不確定都問老師
- 最後要跟老師check報告（如果老師有來現場最好）

2.邱正堂

- 8:00 裝溫水
- 登入好檢查系統(帳號0508 密碼ctchiu8868)
- 髮帽 上面櫃子(不能是綠帽) 內治
- 印上禮拜biopsy結果
- PRN會有作業

超音波**Portable**

1.拿機器: RFA room, 進門左邊, 登記本子
2.收件:
3.上傳:最後一間echo room
(1)影像->電腦:echo接上網路線, 找圖, find, 選today, search, 每一筆都點一次select all, viewer, DICOM, serice, store, 握緊網路線直到螢幕兩條線都跑完
(2)編輯影像:quality control, edit, 名字、生日(斜線)、性別、影像號、點頭像填abd echo, 存檔, back(按yes), open copy, back(按yes), 兩個選起來按send
4.打報告:醫師代號, 按病患點選取, spleen、CBD、portal vein, indication, 結構化

MICU6 總醫師

1. Cover PM off
2. 了解病人狀況, 交班critical condition
3. 幫R2 orientation 通知 要報告ICU conference (檢查報告 & PPT)
4. GI ward 使用Levophed 一律進 ICU
5. 急診要來ICU 一律會診, 內科病房也急會診簽床, 跟老闆告知即可。
6. MICU6簽床
    - 順序:滿床狀況下(原則:GI 本科病房 > 內科> 非本科病房 > 急診 > 其他加護病房轉/借床 > 外院ICU轉床)
7. 外科打來借床(開刀要ICU、擠床...)
    - 一律先檔, 下面有詳細敘述

- 先跟GI自己病房的CR確認病房有無可能需要ICU的case，至少要扣兩張預留的床在自己手上，床位不夠就拒絕
- 若床位寬裕，先問case、underlying、有什麼line（通常其他科會轉比較單純的case）傷口
- 確認共照VS、白班要找誰、值班要找誰（通常對方會給班表）；要強調請對方要打progress note.請他們找床 有床有轉回去 聲明如果擠床會請他們找床
- 跟該段落VS確認是否借床

8. 手上空床維持一床
9. 別科病房插管，說要轉MICU6（MICU135滿床、病人好像有coffee ground…）視同外科借床
   - 非內科病房：他們應該收外科ICU，所以盡量擋，擋到真的找不到床強迫我們收(根據醫院規定，依照順序找床後真的沒床，不能拒收)
     (GS→NS→CVS→M2→M1→CCU→**MICU6**)
   - 非GI內科病房：一律請對方打給急會診，留會診紀錄。
   - 先留病歷號，去看病人狀況
10. 外院ICU轉床：
    - 確認病人姓名、身分證字號、underlying、active problem、藥物、外院電話、聯絡人；務必要確認有符合ICU需要(例如插管…)；先確認手上床位是否寬裕；最後跟VS確認是否接
11. 擋借床（MICU6護理師上下都非常討厭借床）
    - 技巧一：確認前面ICU他們都借過了
      (GS→NS→CVS→M2→M1→CCU→**MICU6**)
    - 技巧二：早上查8ABC護理站patient list，有procedure的床位記下來，打來借床說我們要預留床位給這些procedure病人
    - 若真的擋不了借床，務必請對方換一個單純的case(病房pneumonia插管...)，如果換一個術後肚子一堆管路的，護理師跟阿長會百般刁難，務必注意
12. 如果沒有會診單的病人要進加護病房 或借床
    - 陳醫師 蔡老闆 鄭醫師 可以事後告知
    - 郭醫師即便半夜也要事前取得同意 詢問是否掛combine
    - 蔡老闆說 若借床的病人 有醫療糾紛 或 超級vip 或 iatrogenic 造成併發症 其他科真的沒床 就盡量借 再跟主治醫師確認是否combine
13. 掃蔡銘鴻醫師的病人echo，若有需要幫忙（掃echo），找急檢F2。
14. 尊爵病房病人primary care
15. VIP不住蔡老闆（無法假日查房）
16. 下班前和學弟妹確認有沒有echo影像要上傳（學弟妹有時候會忘記），當天白班要上傳完成。
17. 15:30 前後不要接new pt
18. 完成阿長加護病房表單
19. 洗MARS: (自費一次二十幾萬 一次 = 3 course, 毒素清除比較好一點)
    不需要事前審查
    屬於事後審查的部分(類似開藥抽血，如果不符合indication事後會被健保核刪)
    因此要跟老闆確認好，到底要洗健保還是洗自費(因為事後健保可能會核刪，如果被核刪老闆會被扣錢)
    最保險不會被核刪就是已經配對完成，家屬已經簽好捐贈同意書，以同意書時間就是最準確的
    但是外科的想法是只要開始配對就可以洗健保
    所以還是要跟老闆確認好
    健保可以洗三次

會診腎臟科要16:00以前 需要兩天工作天（D+2 , Ex: W5 申請 W2洗）
盡量不要星期五

學術活動

1. 事前：前一個月底要把學術活動表印出來，和MICU6阿長（護理部最後幾天有meeing）確認後，貼在討論室門口
2. 前一天在teamplus提醒隔天的學術活動，提醒教學門診
3. Teaching round（兩個禮拜前確認case ）
    - 先和負責主治醫師確認時間、地點、題目（兩個禮拜前？？by 彭）
    - 先請學弟妹找case，找不到由我們提供適合的case(務必和主治醫師專業相關)(月初很近的teaching round，請直接提供case給clerk)
    - 確認學弟妹PPT狀況（合理的報告時間順序，特別是lab）
    - 確認場地（和護理長確認該時段MICU6可用，不行要借其他地方）
4. Chart round（和負責主治醫師確認時間、地點，前一天傳訊息提醒主治醫師上課）
    - 至少total 要兩個case admission note!
    - 優先自己admission note, 次之progress note
5. CBL :
6. 教學座談會（和負責主治醫師確認時間、地點，前一天傳訊息提醒主治醫師）
    - 何玉彬：確認only 算clerk+病房CR人數，提前兩天和效慈訂餐盒
    - 李柏賢：確認clerk+R(扣除OFF)+病房CR人數；提前兩天和效慈訂點心
7. Clerk orientation: 分組表 大六不要重複去到同一個station, 教學門診, teaching round case
8. 會議記錄(8D值班室抽屜、兩個禮拜寄給效慈一次(綜合大樓3樓))
    - Teaching round（兩張）
    - Chart round（一張）
    - Morning meeting（一張）
    - IBD conference（一張）
    - 肝癌團隊會議（當場key電腦）
    - GI-GS conference＋胃癌團隊會議 (不用紀錄)
    - Seminar（一張）
    - R3 case conference（兩張）
    - 教學座談會（一張）
    - ICU meeting（一張）
    - Liver CPC（一張）
    - HBV conference（一張）

GIGS

- 個管師：莉玲 66571
- 報告者：病房CR or 當科

HCC conference

- 個管師：靜婷 67648
- 報告者：個管師

HBV conderence

- 前一週聯絡 鄭醫師助理 -林秋慧 (24038126) 要報告個案
- 到6J B肝研究中心拿「紙本」檔案
- 製作成PPT -> 會議當天記得把紙本檔案帶過去
- PPT去MICU-6會議室桌面拿

輪訓與報告統計
中等 rfa ibd 四院區

abc 陳 何 郭4*Fellow seminar + 2次中等報告

d 游 3*fellow + 3次中等報告 其中兩個liver

efg 吳 孟 劉3*fellow + 3次中等報告 + 臨時報告

	沛桓(5)	泰錡(5)	游仁(4)	明蓉(4)	曜瑋(4)	冠廷(4)	昱廷(4)
8	A	C		B IBD	D		
9	Basi腹	Semi腸	D RFA	A Semi膽	Basi食	B IBD	C Semi(肝)
10	Semi腸		C Semi肝	上小 IBD	B Semi膽	D RFA	A Basi胃
11	CD Semi肝	AB Basi大腸	下大	Semi腸 Basi小腸	上小 IBD		HBV
12	Semi膽	Semi膽	HBV	CD	AB IBD	下小	Semi腸
1	上大	Semi肝 下大	四院區 RFA		CD	HBV	AB IBD
2	CD	AB		HBV			
3	Semi膽		AB IBD	CD	Semi肝	HBV Semi腸	
4	CD IBD	RFA	Semi膽	上大	HBV Semi腸	AB Semi肝	下大
5		AB IBD	Semi肝		下大 Semi膽	Semi腸	HBV Semi膽
6		CD IBD	HBV AB	Semi肝		下大	AB Semi腸
7	CD RFA(暑假暫停)		AB		HBV	IBD(暑假暫停)	

	沛桓 (2G+2行)	泰錡 (1G+2行)	游仁 (2G+2行)	明蓉 (2G+1行)	曜瑋 (1G+2行)	冠廷 (2G+2行)	昱廷 (2G+1行)
8		行			G		
9		行+G					
10						G	行
11			G				行
12						G行	
1	G		行				
2			行				G
3	G				行		
4					G	行	
5	行		G				
6				行+G			
7	行			G			

	ward	exam	特休
何沛桓	08, 11, 02, 04, 06	09, 10, 12, 01, 03, 05, 07	12上(小)、01下(大)
吳泰錡	08, 11, 02, 05, 07	09, 10, 12, 01, 03, 04, 06	01上(大)
游仁	09, 10, 03, 07	08, 11, 12, 01, 02, 04, 05, 06	11下(大)
孟明蓉	08, 09, 12, 03	10, 11, 01, 02, 04, 05, 06, 07	10上(小)、04上(大)
郭曜瑋	08, 10, 12, 04	09, 11, 01, 02, 03, 05, 06, 07	11上(小)、05下(大)
劉冠廷	09, 10, 01, 05	08, 11, 12, 02, 03, 04, 06, 07	12下(小)、06下(大)
陳昱廷	09, 10, 01, 06	08, 11, 12, 02, 03, 04, 05, 07	03上(小)、04下(大)

特休

- [ ] 10下 
- [x] 2下 
- [ ] 1上 
- [ ] 11下 
- [ ] 12上 
- [ ] 10上 
- [x] 6下 
- [ ] 3上 

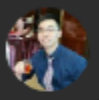
6下



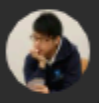
3上



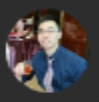
3下



4上



12下



11上



6上



5上

